KNGF-richtlijn
Beroerte

de Fysiotherapeut
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Functionele prognose

Wat is de te verwachten sequentie van functioneel herstel? (0-6 maanden)
(NB sequentie geldt alleen bij hemisferale CVA's)

- **Natuurlijke sequentie mobiliteit:** liggen ▶ zitten ▶ opstaan/gaan zitten ▶ staan ▶ lopen
- **Natuurlijke sequentie basale ADL-vaardigheden:** uiterlijke verzorging ▶ eten ▶ transfers ▶ toiletgebruik ▶ mobiliteit ▶ uit- en aankleden ▶ baden/douchen ▶ traplopen

Wat zijn determinanten van functioneel herstel, hoe worden deze geobjectiveerd en welke meetmomenten worden geadviseerd? (0-6 maanden) — paragraaf D.1

Objectiveer determinanten
- dag 2: loopvaardigheid en arm-handvaardigheid
- dag 5: basale ADL-vaardigheden

Prognose
- **Gunstig:** vervolg: zie diagnostisch proces
- **Ongunstig:**
  - vervolg: zie diagnostisch proces
  - week 0-4: objectiveer determinanten wekelijks
  - maand 1-6: objectiveer determinanten maandelijks

Herstel van	Gunstige determinanten	Operationalisatie gunstige prognose	
loopvaardigheid	- aanwezigheid zitbalans - redelijk tot goede motorische functie paretische been - redelijk tot goede ADL-zelfstandigheid - lagere leeftijd - afwezigheid homonieme hemianopsie - continentie voor urine - premorbide zelfstandige loopvaardigheid - premorbide ADL-zelfstandig	*Beoordeel minimaal:* - zelfstandig 30 seconden ongesteund zitten - geen ernstige parese van het been	TCT - zitbalans: 25 punten MI - onderste extremiteit ≥ 25 punten
arm-handvaardigheid	- enige motorische functie paretische arm - aanwezigheid enige arm-handvaardigheid - aanwezigheid neurofysiologische functies (motor evoked potentials, SEP)	- enige willekeurige vingerextensie - aanwezigheid van minimaal een zichtbare of voelbare contractie van de schouderabductoren	FMA - vingerextensie: ≥ 1 punt MI - schouderabductie: ≥ 9 punten
basale ADL-vaardigheden	- redelijke ADL-zelfstandigheid eind eerste week - redelijk tot goede neurologische status, o.a. motorische functie arm - lagere leeftijd - aanwezigheid loopvaardigheid - premorbide ADL-zelfstandig - premorbide goede participatie - geen recidief-CVA	- beperkte, licht beperkte of geen beperkte ADL-zelfstandigheid aan het eind van de eerste week - matige/milde neurologische uitval	BI eind week 1: ≥ 7 NIHSS: ≤ 7

(NB Determinanten gelden vooral bij CVA's in het voorste stroomgebied van de arteria carotis.)

Hoe wordt het (risico op verslechtering in) functioneren in de chronische fase geëvalueerd en welke meetmomenten worden geadviseerd? — paragraaf D.2

Objectiveer functioneren zes maanden na het CVA

Mobiliteit
- Wel loopvaardig → Indien FAC ≥ 3 en/of hogere corticale functiestoornissen, hoge leeftijd, depressie, vermoeidheid, fysieke inactiviteit leidt tot afname 10MLT comfortabel: ▶ overweeg 6MWT. → Objectiveer loopsnelheid (10MLT comfortabel) zesmaandelijks, inclusief aandacht voor gebruik hulpmiddelen en aandacht voor valincidenten. Bij verandering in functioneren zo nodig herstarten of continueren fysiotherapie (vervolg: zie diagnostisch proces).
- Niet loopvaardig → Objectiveer het zich verplaatsen zesmaandelijks, denk aan: hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel, actieradius, zelfstandigheid, veiligheid. Bij verandering in functioneren zo nodig herstarten of continueren fysiotherapie (vervolg: zie diagnostisch proces), of consulteer een andere discipline met expertise op het betreffende gebied.

Arm-handvaardigheid
- Indien incompleet herstel arm-handvaardigheid (FAT 1-4), somatosensorische functiestoornissen en/of neglect: ▶ overweeg afname ARAT. → Objectiveer arm-handvaardigheid (ARAT) zesmaandelijks. Bij verandering in functioneren zo nodig herstarten of continueren fysiotherapie (vervolg: zie diagnostisch proces).
- Indien FAT 5 en afwezigheid van somatosensorische functiestoornissen en neglect. → Geen verdere actie ondernemen indien er geen aanwijzingen voor dreigende verslechtering van de arm-handvaardigheid; indien achteruitgang wordt verwacht: ▶ overweeg objectiveren armhandvaardigheid (ARAT) zesmaandelijks. Bij veranderingen in functioneren zo nodig herstarten fysiotherapie (vervolg: zie diagnostisch proces).

ADL-vaardigheden
- Objectiveer basale en bijzondere ADL-vaardigheden (BI, NEADL) zesmaandelijks. Verhoogd risico op functionele verslechtering indien incompleet herstel basale en/of bijzondere ADL-vaardigheden en/of hogere corticale functiestoornissen en hoge leeftijd. Bij verandering in functioneren zo nodig herstarten of continueren fysiotherapie (vervolg: zie diagnostisch proces) of consulteer een andere discipline met expertise op het betreffende gebied.

Psychosociaal functioneren en leefstijl
- Patiënt: ▶ overweeg afname MoCA, HADS, SSQoL en fysieke activiteit.
- Partner: ▶ overweeg afname CSI.

→ Bij signalering van probleem: behandelend huisarts of specialist ouderengeneeskunde informeren. Bij behandelmogelijkheden binnen het domein van de fysiotherapie: zie diagnostisch proces.

Diagnostisch proces

Aanmelding (verwijzing)

Algemene patiëntgegevens
- verwijsdiagnose
- lateralisatie CVA
- type CVA
- datum van ontstaan CVA
- recidief-CVA

Overige gegevens
Informatie beschikbaar in het medisch patiëntendossier of in het disciplinedossier van een ander teamlid (intramuraal)

Aanvullende (hetero)anamnese
- voorkeurshand van de patiënt
- pre-existent functioneren
- woonsituatie van de patiënt
- aanwezige aanpassingen/hulpmiddelen
- relevante medische voorgeschiedenis (CIRS)*
- relevante psychiatrische voorgeschiedenis (CIRS)*

* De informatie is mogelijk over te nemen uit het medisch patiëntendossier.

Aanvullend onderzoek
- diagnostische verrichtingen
- gebruik meetinstrumenten **conform stroomdiagram Klinimetrie**
- bevindingen van de fysiotherapeut/resultaten van onderzoek
- stoornissen in functies en beperkingen in activiteiten en participatie: zie **Werkkaart Aanvullend onderzoek**

Analyse
prognostische determinanten: **zie stroomdiagram Functionele prognose**

Therapeutisch proces

Behandelplan
- beoogd interdisciplinair doel
- interdisciplinaire afspraken
- verwachte behandelduur, aantal sessies per week en geplande duur van de sessie(s)?

Behandeling
Zie stroomdiagram **Therapeutisch proces**

Evaluatie
- Afhankelijk van de hulpvraag met daaraan gerelateerde behandeldoelen en/of naar inzicht fysiotherapeut
- Gebruik meetinstrumenten **conform stroomdiagram Klinimetrie**

Afsluiting behandelepisode
- datum en reden van ontslag/afsluiting
- afspraken over nazorg

Klinimetrie

Geadviseerde meetinstrumenten per domein en ICF-niveau		(H)AR	VR	LR	RC	hoofdstuk C
Loopvaardigheid en gerelateerde vaardigheden						
Functies						
MI – onderste extremiteit	spierkracht	●	○	◐	●	
10MLT comfortabel (FAC ≥ 3)	loopsnelheid	●	○	◐	●	
FMA – onderste extremiteit	gedissocieerd bewegen	●	○	◐	●	
10MLT maximaal (FAC ≥ 3)	loopsnelheid	●	○	◐	●	
6MWT (eventueel in combinatie met Borg RPE) (FAC ≥ 3)	loopafstand, functioneel uithoudingsvermogen	●	○	◐	●	
Activiteiten						
TCT	rompactiviteit	●	○	◐	●	
BBS	zit- en stabalans	●	○	◐	●	
FAC	loopvaardigheid	●	○	◐	●	
TIS	zitbalans	●	○	◐	●	
TUG (FAC ≥ 3)	loopvaardigheid	●	○	◐	●	
Arm-handvaardigheid						
Functies						
MI – bovenste extremiteit	spierkracht	●	○	◐	●	
FMA – bovenste extremiteit	gedissocieerd bewegen	●	○	◐	●	
Activiteiten						
FAT*	arm-handvaardigheid	●	○	◐	●	
ARAT*	arm-handvaardigheid	●	○	◐	●	
NHPT*	arm-handvaardigheid	●	○	◐	●	
Basale ADL-vaardigheden						
Activiteiten						
BI**	basale ADL-vaardigheden	●[a]	○	◐	●	
Bijzondere ADL-vaardigheden						
Activiteiten						
NEADL	bijzondere ADL-vaardigheden	●[a]	○	◐	●	
Ervaren kwaliteit van leven						
Participatie						
SSQOL	kwaliteit van leven				●	
Overig						
Functies						
NNM	bewegingsuitslag	●	○	◐	●	
MAS	weerstand tegen passief bewegen	●	○	◐	●	
EmNSA	somatosensoriek	●	○	◐	●	
NIHSS***	neurologische stoornissen	●	○			
CIRS	multimorbiditeiten	●	○	◐	●	
NPRS	pijnbeleving	●	○	◐	●	
FES	self-efficacy bij balanshandhaving	●	○	◐	●	
FSS[a]	vermoeidheid			◐	●	
HADS[b,c]	angst en depressie		○	◐	●	
MoCA[b]	cognitieve functies	●	○	◐	●	
O-LCT[b]	neglect	●	○	◐	●	
Activiteiten						
mRS	functionele status	●	○	◐	●	
Externe factoren						
CSI[d]	belasting mantelzorger		○	◐	●	

Geadviseerde meetmomenten	(H)AR	VR	LR	RC	hoofdstuk C
Basismeetinstrumenten					
Altijd afnemen					
tijdens het diagnostisch proces	●	○	◐		
bij afsluiting van de behandelperiode en bij overdracht van de patiënt aan een collega-fysiotherapeut	●	○	◐		
aan het eind van de eerste week, na drie en na zes maanden na ontstaan van het CVA		○	◐		
Contextafhankelijk afnemen:					
vlak voor elke interdisciplinair overleg (functionele [revalidatie]uitkomsten)	●	○	◐	●	
moment van afname afhankelijk van hulpvraag patiënt met de daaraan gerelateerde behandeldoelen en/of naar het inzicht van de fysiotherapeut				●	
Aanbevolen meetinstrumenten					
Contextafhankelijk afnemen:					
moment van afname afhankelijk van hulpvraag patiënt met de daaraan gerelateerde behandeldoelen en/of naar het inzicht van de fysiotherapeut	●	○	◐	●	

(H)AR = (hyper)acute (revalidatie)fase; VR = vroege revalidatiefase; LR = late revalidatiefase; RC = revalidatie in de chronische fase.
● De fase waarin het basismeetinstrument/aanbevolen meetinstrument wordt afgenomen.

10MLT = Tien-meter looptest; 6MWT = Zes-minuten wandeltest; ARAT = Action Research Arm Test; BI = Barthel Index; BBS = Berg Balance Scale; Borg RPE = Borg Rating of Perceived Exertion; CIRS = Cumulative Illness Rating Scale; CSI = Caregiver Strain Index; EmNSA = Erasmus MC modificatie van het (revised) Nottingham Sensory Assessment; FAC = Functional Ambulation Categories; FAT = Frenchay Arm Test; FES = Falls-Efficacy Scale; FMA = Fugl-Meyer Assessment; FSS = Fatigue Severity Scale; HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale; MAS = Modified Ashworth Scale; MI = Motricity Index; MoCA = Montreal Cognitive Assessment; mRS = Modified Rankin Scale; NEADL = Nottingham Extended ADL index; NIHSS = National Institutes of Health Stroke Scale; NHPT = Nine Hole Peg Test; NNM = Goniometer volgens de Neutrale-0-Methode; NPRS = Numeric Pain Rating Scale; O-LCT = O-Letter Cancellation Test; SSQoL = Stroke-Specific Quality Of Life scale; TCT = Trunk Control Test; TIS = Trunk Impairment Scale; TUG = Timed Up and Go test.

a Om de premorbide situatie vast te stellen. b Bedoeld als signalering; behandeling hiervan ligt niet primair binnen het domein van de Fysiotherapie. c Af te nemen vanaf 7 dagen na het CVA. d Na ontslag naar huis of na proefverlof, én er een mantelzorger aanwezig is.
* Mogelijk over te nemen uit het ergotherapeutisch dossier. ** Mogelijk over te nemen uit het verpleegkundig dossier. *** Mogelijk over te nemen uit het medisch dossier.

© KNGF

Therapeutisch proces

Interventie?

Is mobilisatie < 24 uur na ontstaan van het CVA mogelijk?

Evaluatie:
Welke meetinstrumenten?
Zie **stroomdiagram Klinimetrie.**

Nee (alleen van toepassing indien mobilisatie is gecontra-indiceerd)

Zijn er tijdens liggen problemen met:
- lighoudingen in bed?
- veranderingen van lighouding?
- ventilatie van de luchtwegen?*

Maatregelen	Paragraaf
▶ positionering van de paretische zijde	E.5
▶ decubituspreventie (wisselliggingsschema's)	E.5
▶ ademhalingsoefeningen en manuele ondersteuning	E.5

Zijn er complicaties te verwachten tijdens het liggen?
- bronchopneumonie?
- diepveneuze trombose?

Maatregelen	
▶ houdingsveranderingen in lig	E.5
▶ controle op pijn, oedeem en koorts	E.5

* Drainagehoudingen zijn relatieve contra-indicaties bij een bloedig CVA.

Ja — **Zijn er beperkingen in activiteiten tijdens het lopen of daaraan gerelateerde functies en activiteiten?**

Overweeg interventie (alleen niveau 1)

Interventie:	Woeglijdige mobilisatie uit bed	Oefenen van het evenwicht in zit	Oefenen van opstaan en gaan zitten	Evenwicht in stand zonder visuele feedback	Houdingscontrole in stand met visuele feedback	Evenwicht tijdens verschillende activiteiten	Loopbandtraining met gewichtsondersteuning	Robotgeassisteerde looptraining*	Loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning	Looptraining over een vaste ondergrond**	Looptraining met externe audiotiere ritmen	Looptraining in een openbare ruimte	Training van de mobiliteit in een virtuele omgeving	Groepstraining met werkstations	Oefenen met een mantelzorger	Spierkrachttraining paretische been	Aerobe training	Gecombineerde spierkracht- en aerobe training	Training in het water (hydrotherapie)	Interventies voor somatosensorische functies	Elektrostimulatie van het paretische been - TENS	Elektrostimulatie van het paretische been - NMS	Elektrostimulatie van het paretische been - EMG-NMS	Biofeedback van het paretische been
paragraaf:	F.1.1	F.1.2	F.1.3	F.1.4	F.1.5	F.1.6	F.1.7	F.1.8	F.1.9	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.1	F.1.2	F.1.2	F.1.2	F.1.2	F.1.2
Beperkingen op ICF-niveau per lichaamsfunctie																								
- gedissocieerd bewegen					=		=	=								=	=	✓		=		✓		
- spierkracht								=						=		✓	=	✓	✓		✓	✓		
- weerstand tegen passief bewegen																✓					=	✓	=	
- actieve bewegingsuitslag																					=	=		=
- EMG-activiteit																								=
- comfortabele loopsnelheid					=	=	✓	=	=	=	=		=	=		=	=	✓		=	=	=		=
- maximale loopsnelheid							=	✓	✓	=		=	=			=	=	✓						
- loopafstand							✓	✓	=	✓		=		✓		=	=	✓			=			
- spatiotemporele parameters					=		=	=	✓	=	=		=			✓						=		=
- houdingszwaai				=	✓																			
- symmetrie grondreactiekrachten		=	=																					
- hartfrequentie							✓			=						=	=	✓						
- bloeddruk										=							=							
- aerobe uithoudingsvermogen							=		=	×						=	✓	✓						
- energieverbruik							=									=	=	=						
- vermogen ('workload')																=	✓							
- respiratoire functies																	✓							
- angst										✓														
- depressie										=				=				=						
- vermoeidheid	=																							
- valangst						=						=		=										
- complicaties	=																							
- neurologische functies	=							=																
- valincidenten										=				=										
Activiteiten en participatie																								
- zitbalans		✓		=	=	✓	=	✓	=	=				✓			=	✓	=	=		=		
- snelheid reiken in zit		✓																						
- stabalans				=	=	✓	=	✓	=	=				✓			=	✓	=	=		=		
- opstaan en gaan zitten			=	=																				
- loopvaardigheid		=		=	=	=	=	✓	=	=			=	✓		=	=	=			✓	=		
- basale ADL-vaardigheden	=	=			=	✓		✓		=				=	✓	=		=				=	=	
- instrumentele ADL-vaardigheden										=				=	=			=						
- fysieke activiteit dagelijks leven														✓				✓						
- kwaliteit van leven				=	=	=								=		=		✓						
Contextuele factoren																								
- ervaren zorglast mantelzorger															✓									
- ontslag naar huis	=																							

✓ effectief; = geen meerwaarde; × nadelig effect. * Effect comfortabele loopsnelheid, zitbalans, stabalans en loopvaardigheid geldt alleen voor niet-zelfstandig lopende patiënten. ** Nadelig effect op het aerobe uithoudingsvermogen geldt alleen voor patiënten in de vroege revalidatiefase, effect loopafstand en angst geldt voor zelfstandig lopende patiënten.

Therapeutisch proces

Ja — **Zijn er beperkingen in de arm-handvaardigheid en daaraan gerelateerde functies en activiteiten?**

Overweeg interventie (alleen niveau 1)

Interventie:	Therapeutisch positioneren van de paretische arm*	Reflex-inhiberende houdingen en immobilisatietechnieken pols en hand	Het gebruik van air-splints en wrapping rondom de paretische arm en hand	Ondersteunende technieken hulpmiddelen GHS en/of HSP	Bilaterale armtraining	Originele CIMT	Hoge intensiteit mCIMT	Lage intensiteit mCIMT	Immobilisatie van de niet-paretische arm zonder specifieke training van de paretische arm	Robotgeassisteerde training schouder-ellebOog - unilateraal***	Robotgeassisteerde training ellebOog-pols - bilateraal**	Robotgeassisteerde training arm-hand	Spiegeltherapie voor de paretische arm	Training van de paretische arm in een virtuele omgeving	Elektrostimulatie van de paretische arm - TENS	Elektrostimulatie van de paretische pols-/vingerextensoren - NMS	Elektrostimulatie van de paretische pols-/vingerextensoren en -flexoren - NMS	Elektrostimulatie van de paretische schouder - NMS	Elektrostimulatie van de paretische pols-/vingerextensoren - EMG-NMS	Elektrostimulatie van de paretische pols-/vingerextensoren en -flexoren - EMG-NMS	EMG-biofeedback voor de paretische arm	Spierkrachttraining van de paretische arm	Fixatie van de romp tijdens training van de paretische arm	Interventies voor somatosensorische functies
paragraaf:	F.4.1	F.4.2	F.4.3	F.4.4	F.4.5	F.4.6	F.4.6	F.4.6	F.4.6	F.4.7	F.4.7	F.4.7	F.4.8	F.4.9	F.4.10	F.4.10	F.4.10	F.4.10	F.4.10	F.4.10	F.4.11	F.4.12	F.4.13	F.4.14
Beperking op ICF-niveau per lichaamsfunctie																								
- gedissocieerd bewegen			=	=	=		=	✓		✓	✓	=	=	=		=	✓	=	✓	=	=	=		=
- spierkracht					=					✓	✓	=				=	✓		=			=		=
- weerstand tegen passief bewegen		=	=							=			=	×	=				=					✓
- actieve bewegingsuitslag																=		=	✓		=	=	=	
- passieve bewegingsuitslag	✓	=																						
- pijn	=	=	=	=						✓			=					=				=		=
- glenohumerale subluxatie																		✓						
- somatosensorische functie			=																					✓
Activiteiten en participatie																								
- arm-handvaardigheid			=		=	✓	✓	✓		=			=	=		=	=		✓	=	=	=	=	=
- ervaren gebruik arm-hand					=	✓	✓	✓															×	
- ervaren kwaliteit bewegen arm-hand						✓	✓	✓																
- basale ADL-vaardigheden	=				=		=	✓		=				✓	=									
- kwaliteit van leven								=		=														

✓ effectief; = geen meerwaarde; × nadelig effect. * Het effect op passieve bewegingsuitslag is niet klinisch relevant. ** Bij gelijke dosering even effectief als andere vormen van oefentherapie.

Therapeutisch proces

Ja

Zijn er beperkingen in activiteiten tijdens het lopen of daaraan gerelateerde functies en activiteiten?

Overweeg interventie (alleen niveau 2)

Interventie:	Bilaterale beentraining met ritmisch auditieve cueing	Spiegeltherapie voor het paretische been	Limb overloading met externe gewichten aan de paretische zijde	Systematisch geven van feedback over loopsnelheid	Behoud van enkelconsolidatie middels een statief of nachtspalk	Manuele passieve gewrichtsmobilisaties van de enkel*	Oefeningen voor de bewegingsuitslag enkel met apparatuur	Ultrageluid voor het paretische been	Segmentale spierinhibatie bij een voetheffersparese	Oefenen op een trimpaat
paragraaf:	F.2.1	F.2.2	F.2.3	F.2.4	F.2.5	F.2.6	F.2.7	F.2.8	F.2.9	F.2.10
Beperking op ICF-niveau per lichaamsfunctie										
- gedissocieerd bewegen	=	✓								
- spierkracht							=			=
- weerstand tegen passief bewegen		=					=	=		
- Hmax/Mmax-ratio								✓		
- bewegingsuitslag					=	✓	=	=		
- somatosensorische functie										=
- loopsnelheid	=		=	✓			=		=	
- symmetrie grondreactiekrachten					=					
- loopafstand				=			=			
- spatiotemporele parameters									=	
- kinematische maten									✓	
- elektromyografische functies									✓	
Activiteiten en participatie										
- zit- en stabalans			×				=			=
- opstaan uit een stoel					=					
- snelheid opstaan en gaan zitten						×				
- loopvaardigheid		=		=		=	=			=
- basale ADL-vaardigheden		✓					=			=
Contextuele factoren										
- opnameduur				=						
- kwaliteit van leven				=						

✓ effectief; = geen meerwaarde; × nadelig effect. * Het effect op passieve bewegingsuitslag is niet klinisch relevant. ** Bij gelijke dosering even effectief als andere vormen van oefentherapie.

Zijn er beperkingen in arm-handvaardigheid en daaraan gerelateerde functies en activiteiten?

Overweeg interventie (alleen niveau 2)

Interventie:	Continuous passive motion voor de schouder	Subsensorische elektrische vibratiestimulatie van de paretische arm	Groepstraining met werkstations	Passieve bilaterale armtraining	Mechanische armtrainer
paragraaf:	F.5.1	F.5.2	F.5.3	F.5.4	F.5.5
Beperking op ICF-niveau per lichaamsfunctie					
- gedissocieerd bewegen		=	✓	=	=
- spierkracht	=			=	=
- weerstand tegen passief bewegen	=				
- gewrichtsstabiliteit schouder	=				
- pijn	=				
- somatosensorische functie		×			
- neurologische functies				=	
- neurofysiologische maten				✓	
Activiteiten en participatie					
- arm-handvaardigheid		=	✓		✓
- basale ADL-vaardigheden	=				=
- kwaliteit van leven		=			

✓ effectief; = geen meerwaarde; × nadelig effect.

Algemene (behandel)mogelijkheden		paragraaf
teleconsultatie/-revalidatie	ter facilitatie van zelfmanagement, zelfstandig oefenen en empowerment in de eigen woon- en leefomgeving (niveau 2)	B.6
zelfmanagement	ter facilitatie van regie en eigen initiatief	B.7
leefstijlprogramma's	met aerobe training (klinimetrie en opbouw programma *KGNF-richtlijn Hartrevalidatie*) ter vermindering van risicofactoren voor CVA bij TIA of 'minor stroke' in voorgeschiedenis (niveau 2)	B.8
valpreventie	ter verbetering van loopvaardigheid, inclusief screening op verhoogd valrisico en uitvoeren multifactoriële behandelstrategie (niveau 4)	B.9

Zijn er hulpmiddelen nodig ter verbetering van het zich verplaatsen?		paragraaf
loophulpmiddelen	ter verbetering van de loopvaardigheid (veiligheid, zelfstandigheid, efficiëntie, zelfvertrouwen) (niveau 2)	F.3.1
beenorthesen	ter verbetering van de loopvaardigheid (loopsnelheid, energieverbruik, loopafstand) (niveau 2)	F.3.2
rolstoel	ter verbetering van het zich verplaatsen bij patiënten die niet ambulant zijn (veiligheid, zelfstandigheid, actieradius) (niveau 4)	F.3.3

Zijn er beperkingen in overige vaardigheden van ADL wat betreft:		paragraaf
dyspraxie?	overleg met ergotherapeut en/of (neuro)psycholoog: strategietraining; gebarentraining ('gestural training')	F.6.2
vrijetijdsbesteding?	overleg met ergotherapeut: (her)leren en hervatten vrijetijds- of dagbesteding in de thuissituatie	F.6.3

Zijn er beperkingen in cognitieve vaardigheden wat betreft:		paragraaf
vasthouden van de aandacht?	overleg met (neuro)psycholoog: training compensatiestrategieën	G.1
het onthouden?	overleg met (neuro)psycholoog: strategietraining met gebruik van interne en/of externe strategieën	G.2
aandacht voor de verwaarloosde zijde?	overleg met (neuro)psycholoog: visuele scanningtraining	G.3

KNGF-richtlijn
Beroerte

de Fysiotherapeut
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

© KNGF